

+ 医知創造ラボ

中枢神経原発血管炎 (PACNS / PCNSV)

画像だけで決めない 診断・鑑別・治療【ESO2023 / Rice
2026】

NEURO

医療従事者向け

稀だが治療可能。 でも画像だけでは決まらない？

結論

- ① 画像だけで決めない
(DSA陽性≠確定・陰性≠除外)
- ② 免疫抑制の前にRCVS・感染・腫瘍を除外
- ③ 稀だが治療可能(維持は少なくとも2年)

PACNSを5つの問いで整理する

1 PACNSとは・どう分類するか

2 どんな臨床像で疑うか

3 何を”除外”するか(最重要)

4 どう診断を確定するか

5 どう治療し、予後はどうか

■ CHAPTER 01

① PACNSとは・ どう分類するか

脳・脊髄・髄膜の血管壁に 限局する炎症

まず**一次性 vs 二次性**を分ける。二次性を一つずつ外して初めて**一次性 (PACNS)**と診断できます。

二次性として外すべきもの

全身性血管炎・膠原病／感染(VZV・結核・梅毒・HIV・真菌)／感染性心内膜炎／薬剤(コカイン等)／腫瘍。**一次性＝他に原因がないこと。**

分類の3軸で捉える

軸	内容
血管径	大／中血管型＝DSAで見えやすい(angiography-positive)／小血管型＝DSA陰性でも生検陽性になりやすい
病理	肉芽腫性58％・リンパ球性28％・壊死性14％(肉芽腫の一部は β A4沈着＝ABRA)
特殊型	ABRA・腫瘤様・片側再発

⚠ 注意

病理型だけで治療を変えない(ESO2023)。

■ EPIDEMIOLOGY

2.4/100万人・年

年間発症率は約2.4/100万人・年と稀

発症年齢中央値は約50歳(Mayoは48歳)/性差は一定しない

どの年齢でも起こりうる

■ CHAPTER 02

② どんな臨床像で 疑うか

典型症状はない

- ✓ 頭痛・認知機能低下が背景に多い
- ✓ 脳卒中(局所神経脱落)・失語・片麻痺・視覚障害・けいれん
- ✓ これらが多彩に組み合わせる
- ✓ 経過は急性～慢性、再発寛解もとる

ここがポイント

「片麻痺だけ」「頭痛だけ」では捉えられない。
多彩さと経過の幅で疑う。

MRIの4パターン

- ✓ 多発虚血病変(新旧混在DWI)
- ✓ 非特異的白質病変(T2／FLAIR・約1／3で髄膜増強)
- ✓ 造影病変・髄膜増強(点状／線状／結節状)
- ✓ 出血性病変(SWI微小出血)

生検陽性56例:SWI出血96.4%・造影病変96.3%・dot-linear 87%(小血管型のヒント)

■ CHAPTER 03

③ 何を”除外”するか (最重要)

最重要鑑別はRCVS

RCVS 雷鳴頭痛・女性優位・産後／血管作動薬

数週～3ヶ月で可逆。髄液は概ね正常。

PACNS 持続性病変／髄液異常が出やすい

注：HRVWI単独で診断しない(ESO2023)。

免疫抑制の前に外す



感染性心内膜炎

血液培養＋心エコーを省くと誤る。



VZV vasculopathy・他の感染

皮疹なしでも起こる(CSF VZV IgG index／PCR)。
結核・梅毒・HIV・真菌も意識。



腫瘍様型

gliomaやリンパ腫と誤認しうる。だからこそ生検の意義が高い。

主要鑑別の早見表

疾患	手掛かり	髄液	決め手
RCVS	雷鳴頭痛・可逆	正常	数週～3ヶ月で改善・ 免疫抑制不要
感染性心内膜炎	心雑音・塞栓	非特異	血培・経食道心エコー
CAA関連／ABRA	高齢・認知変動・微小出血	軽度炎症	生検でA β
中枢神経リンパ腫	亜急性・腫瘤効果	細胞診	生検
Susac	網膜分枝閉塞・難聴・脳梁病変	軽度	脳梁中心病変

検査の読み方

検査	読み方
MRI	90%超で異常だが非特異的
髄液	80～90%異常だが除外目的(正常でも否定不可)
DSA	beadingは感度特異度に限界。陽性≠確定・陰性≠除外
HRVWI	同心円状壁造影は補助的(標準化不十分)
生検	確定の基準。陽性率約63%(感度50～70%)。 skip lesionで陰性でも除外不可。MRI異常／造影／髄膜増強をターゲットに 皮質＋軟膜を採る

基準の変遷と実践

Calabrese & Mallek
1988(古典)

Birnbaum & Hellmann
2009 definite / probable

Rice & Scolding
definite=組織 / possible

安易にdefiniteと読まない

実践3点(ESO2023)

- ① 感染除外を先に
- ② MRA正常でもDSA
- ③ 小血管型は生検へ

治療は導入→維持

- ✓ 導入:mPSL 1g×3日 → PSL 1mg/kg(±cyclophosphamide/MMF)
- ✓ 感染が否定できないうちは免疫抑制を急がない
- ✓ 維持:AZA/MMTX/MMFで少なくとも2年
- ✓ 難治・再発:rituximab

反応・再発

良好反応:PSL単独85%/併用80%。再発27%。

PSL単独は再発が多い。

3つのキーマッセージ

01

画像だけで決めない

DSA陽性≠確定・陰性≠除外。HRVWI単独でも診断しない。

02

先にRCVS・感染・腫瘍を除外

免疫抑制の前に、感染性心内膜炎やVZVを必ず外す。

03

稀だが治療可能

導入後の維持は少なくとも2年。難治・再発はrituximab。

+ 医知創造ラボ

本スライドは医療従事者向けの情報提供であり、個々の診療判断に代わるものではありません。